Krankenhausentlassbrief

[Elemente: **fett-unterstrichen** = mandatory / unterstrichen = optional]

Entlassende Einrichtung

Name: Krankenhaus XYZ, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
Anschrift: Straße 2, 10102 Berlin
Kontaktkanal: Telefon 030 987654321
Verantwortliche Person:
Dr. Ralf Obenauf; Oberarzt
Behandelnde Person:
Dr. Ralf Obenauf

Kontakt Entlassmanagement

Kontaktkanal: Telefon 030 1234566
Kontaktzeiten: Montag bis Freitag in der Zeit von 09:00 bis 19:00, Samstag 10:00 bis 14:00, Sonntag 10:00 bis 14:00 Uhr

Empfangende Person

Name: Dr. Petra Semmelbruch
Funktionsbezeichnung: FA für Orthopädie
Rolle: Weiterbehandelnder Arzt/Weiterbehandelnde Ärztin
Anschrift: Straße 3, 10103 Berlin
Kontaktkanal: Telefon 030 0987654321

PatientIn

Nachname, Vorname	
Paul, Pia	

Falldaten

Aufnahmedatum	**Entlassdatum**
01.04.2022	06.04.2022
Zustimmung Entlassmanagement	**Einwilligung Unterstützung durch die Kranken-/Pflegekasse**
ja	ja
Aufnahmeanlass	**Fachabteilungsschlüssel**
E Einweisung durch den Arzt	2316 Orthopädie und Unfallchirurgie
Entlassgrund	
01 Behandlung regulär beendet	

Metadaten

Kennzeichnung Entlassbrief	**Erstellungszeitpunkt**
final	06.04.2022

Aufnahme

Aufnahmediagnosen	Code/Bezeichnung: M16.1 Sonstige primäre Koxarthrose Freitextbeschreibung: rechts; Kellgren-Lawrence-Score 4

Anamnese

Anamnestische Diagnosen	Code/Bezeichnung: M16.1 Sonstige primäre Koxarthrose Freitextbeschreibung: rechts; Kellgren-Lawrence-Score 4
	Code/Bezeichnung: E11.90: Diabetes mellitus, Typ 2 Freitextbeschreibung: Ohne Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet

Verlauf

	Überschrift: Implantation TEP **Inhalt**: Minimalinvasive Implantation einer nicht zementierten Totalendoprothese am Hüftgelenk rechts am 02.04.2020

Entlassungsbefund

	Reizlose und trockene Wunde, resorbierbare Nahtmaterial in situ, Mobilisation im 4. Punkt-Gang mit schmerzadaptierter Vollbelastung des operierten Beines

Weiteres Prozedere und Empfehlungen

	Wir entlassen Frau Paul heute aus unserer stationären Behandlung in die Häuslichkeit. Wir bitten um regelmäßige klinische Verlaufskontrollen. Ein Fadenzug ist bei dem resorbierbaren Nahtmaterial nicht notwendig. Eine AHB wurde von uns beantragt, Ort und Termin werden der Patientin vom Versicherungsträger direkt mitgeteilt.“